PROTOCOLLO 77

Rilascio e mobilità cervicale globale

Ridurre la tensione cervicale prima del lavoro mandibolare

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	DTM con componente cervicale	5 minuti	Ogni seduta

Indicazioni

- ✓ Tensione cervicale diffusa
- ✓ Dolore muscolare cervicale
- ✓ Preparazione alla terapia mandibolare

Controindicazioni e precauzioni

- ! Segni di insufficienza vascolare (vertigini, diplopia, disartria, disfagia)
- ! Instabilità cervicale sospetta (traumi, artrite reumatoide)
- ! Sintomi neurologici agli arti superiori
- ! Trauma cervicale recente non valutato dal medico

Posizionamento

Paziente: supino, capo in posizione neutra.

Fisioterapista: alla testa del lettino.

Esecuzione passo dopo passo



Trazione

Lieve trazione cervicale manuale.



Rotazioni

Rotazioni passive lente nel range libero.



Inclinazioni

Inclinazioni laterali dolci.



Rilascio

Termina con il rilascio suboccipitale.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Durata	5 minuti
Ritmo	lento
Intensità	confortevole

Criteri di rivalutazione

DOLORE CERVICALE (NRS)
____ / 10
a riposo e in movimento

MOBILITÀ
____°
rotazione o flessione

SINTOMI MANDIBOLARI
Migliorati / Invariati
dopo il trattamento

Punti chiave

- ✓ Prepara bene il terreno al lavoro locale
- ✓ Movimenti lenti
- ✓ Osserva il rilassamento

Errori da evitare

- ! Movimenti ampi e rapidi
- ! Ignorare vertigini
- ! Trazioni forti

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Mobilità attiva	Rotazioni e inclinazioni lente del capo	5 per direzione, 2 volte al giorno

! **Nota clinica.** Ridurre la tensione cervicale facilita il trattamento dei masticatori.

Bibliografia essenziale

1. La Touche R. et al. The effects of manual therapy and exercise directed at the cervical spine on pain and pressure pain sensitivity in patients with myofascial temporomandibular disorders. J Oral Rehabil. 2009;36(9):644–652.
2. Jull G.A., O'Leary S.P., Falla D.L. Clinical assessment of the deep cervical flexor muscles: the craniocervical flexion test. J Manipulative Physiol Ther. 2008;31(7):525–533.